

## การจัดการความรู้ภาควิชา การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 8.00-9.00 น. เรื่อง "การคลอดไหล่ยาก"

คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และการจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การคลอดไหล่ยาก" โดยมี ผศ.วาสนา จิตมา อาจารย์ประจำของภาควิชาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุม 1103/1-2 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิยามการคลอดไหล่ยาก คือ ภาวะที่ภายหลังศีรษะทารกคลอดออกมาแล้ว บริเวณไหล่มีการติดแน่นที่บริเวณใต้รอยต่อกระดูกหัวเหน่า ทำให้ไม่สามารถคลอดส่วนของลำตัวทารกได้ตามวิธีการช่วยคลอดปกติ นับเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่มารดาและทารกได้

### ปัจจัยเสี่ยง

- ทารกน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม
- สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
- สตรีตั้งครรภ์อ้วน - ตั้งครรภ์เกินกำหนด
- กราฟการคลอดมีความผิดปกติ
- มีประวัติคลอดติดไหล่
- ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

### ภาวะแทรกซ้อนต่อสตรีตั้งครรภ์

- ตกเลือดหลังคลอด
- มดลูกแตก
- ช่องคลอดฉีกขาดมาก

### ภาวะแทรกซ้อนต่อทารก

- มีภาวะขาดออกซิเจน
- กระดูกไหปลาร้า/ต้นแขนหัก
- บาดเจ็บต่อ brachial plexus
- เสียชีวิต

### การวินิจฉัยว่ามีภาวะคลอดไหล่ยาก

ภายหลังศีรษะทารกเกิดถ้านิ้วไหล่บนไม่ลงประมาณ 2 ครั้งให้พิจารณาว่ามีอาการแสดงดังนี้หรือไม่

- ขณะมดลูกหดตัวเมื่อให้แม่ช่วยเบ่งแล้วไหล่บนไม่คลอดเพิ่ม
- หลังแม่เบ่งศีรษะทารกเลื่อนกลับเข้าไปที่ฝีเย็บแม่คล้ายหลังเต่า(turtle sign) แสดงว่ามีภาวะคลอดไหล่ยาก 2

## แนวทางการดูแล

เมื่อเกิดภาวะคลอดไหล่ยากให้ดำเนินการดังนี้

A Ask for help

L Lift the legs

A Anterior shoulder disimpaction

R Rotation of posterior shoulder

M Manual removal posterior arm

### Ask for help (ร้องขอความช่วยเหลือ)

ในทุกๆรายของการช่วยคลอดต้องเตรียมพร้อม"ช่วยคลอดไหล่ยาก"เสมอ พยาบาลในห้องคลอดจึงควรมีการแบ่งบทบาทให้ชัดเจนว่าเมื่อเกิดภาวะนี้แต่ละคนจะมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้คลอดอย่างไร อาจมีการตั้งรหัสที่ทำให้ทุกคนเข้าใจเมื่อเกิดภาวะนี้สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่สามารถมาให้การช่วยได้ทันที และบอกให้ผู้คลอดหยุดเบ่ง

### Lift the legs (McRobert's maneuver)

ผู้ช่วยคลอดจัดท่าผู้คลอดโดยยกขาผู้คลอดขึ้นและงอพับเข้าไปกับหน้าท้องร่วมกับการจัดท่าให้ศีรษะอยู่ในแนวราบ เพื่อเปลี่ยนมุมของอุ้งเชิงกราน

### Anterior shoulder disimpaction(Suprapubic pressure)

เป็นการทำคลอดไหล่หน้าให้หลุดออกมาจากรอยต่อกระดูกหัวหน้าว ก่อนทำต้องตัดฝีเย็บเพิ่มขึ้น ผู้ช่วยใช้สันมือกดลงบริเวณเหนือหัวหน้าว (ตรงกับสะบักหลังของทารก)อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับผู้ทำคลอดดึงศีรษะของทารกลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ออกแรงดึงศีรษะทารกอย่างแรง ไม่โยกศีรษะทารกไปมาและไม่ให้กอดต้นยอดมดลูก ส่วนใหญ่ทำร่วมกับMcRobert's maneuver ซึ่งมักได้ผลร้อยละ 91

ผู้ทำคลอดอาจสอดมือเข้าไปในช่องคลอดผลักด้านหลังของไหล่บนเพื่อให้ไหล่งอเข้ามาหาหน้าอก (Rubin's maneuver)

### Rotation of posterior shoulder (Woods maneuver)

เป็นการทำให้ไหล่ทารกคลอดโดยการหมุนไหล่หลังมาข้างหน้าแล้วสอดมือเข้าไปทางด้านหลังของไหล่หลัง ออกแรงผลักหลังหมุนทารกแบบเกลียวไปทางด้านหน้าจนไหล่หลังที่ผลักเปลี่ยนมาอยู่ด้านหน้าได้รอยต่อกระดูกหัวหน้าว

### Manual removal posterior arm

เป็นการทำคลอดไหล่หลังก่อนโดยสอดมือเข้าไปปาดแขนหลังผ่านทางหน้าอกทารกแล้วทำคลอดแขนและไหล่หลัง จึงทำคลอดไหล่หน้าต่อ ไม่นิยมเพราะโอกาสเสี่ยงต่อการหักของกระดูกต้นแขนของทารกได้มาก

**การบันทึกการช่วยคลอด** มีความสำคัญในการให้การดูแลต่อเนื่องและเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเกิดคดีความได้ ข้อมูลที่ควรมี ได้แก่

- เวลา : คลอดศีรษะ, ไหล่, เกิด
- การตัดฝีเย็บ
- เวลาที่ตัดสินใจว่ามีภาวะคลอดไหล่ยาก
- Maneuver ที่ใช้ เรียงตามลำดับ และระยะเวลา
- บุคลากรที่ช่วย
- ลักษณะของทารก : ท่า น้ำหนักตัว สภาพแรกเกิด APGAR Score ลักษณะการหายใจ การเคลื่อนไหวของแขนและขา ร้อยละของออกซิเจนในเลือด

ผศ.วาสนา จิตติมา เป็นผู้ถอดบทเรียน

### รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. รศ. ศิริวรรณ สันทัด
2. รศ. ยุวดี วัฒนานนท์
3. ผศ. ทศนีย์วรรณ พุกษามะธานนท์
4. ผศ. นิตยา สิ้นสุกใส
5. ผศ. กันยรักษ์ เสงยเจริญ
6. ผศ. วาสนา จิตติมา
7. ผศ. จรรยา เจริญสุข
8. ผศ. ปิยะนันท์ ลิ้มเรืองรอง
9. อ.ศุภาวดี วายุเหือด
10. อ.ฤดี ปุ๋งบางกะดี
11. อ.รุ่งทิพย์ กาศักดิ์
12. อ.พุทธิราภรณ์ หังสนันส
13. อ.กุลธิดา หัตถกิจพานิชกุล
14. อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์
15. อ.อรรพรรณ พินิจเลิศสกุล
16. อ.จิรันทา อ่อนเจริญ
17. อ.รุ่งนภา รัชชอบ
18. อ.นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธิ